

Etablissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI

Chute

Conduite à tenir devant chute simple ou chute avec impact potentiel, avec évaluation initiale et critères d'alerte.

Indications

- Chute observée ou résident retrouvé après coup.
- Absence de détresse immédiate évidente.
- Besoin d'évaluation initiale structurée.

Vérifications préalables

- Ne pas relever immédiatement sans évaluation sommaire.
- Rechercher douleur, traumatisme crânien, plaie, déformation, déficit ou malaise.
- Vérifier anticoagulant/antiagrégant, contexte syncopal et heure de chute.
- Prendre paramètres si cela ne retarde pas l'alerte.

Ne pas appliquer ce protocole

- Trouble de conscience, douleur majeure, suspicion de fracture.
- Traumatisme crânien avec anticoagulant ou signe neurologique.
- Douleur rachidienne importante ou suspicion cervicale.
- Contexte de malaise, douleur thoracique ou dyspnée.

Conduite à tenir

- Si état rassurant : relever avec aide adaptée et réinstaller.
- Soins locaux simples si plaie superficielle selon protocole.
- Prévenir IDE/médecin selon contexte et antécédents.
- Analyser circonstances et facteurs favorisants ; déclarer la chute si requis.

Surveillance et traçabilité

- Tracer heure, circonstances, examen sommaire et paramètres utiles.
- Surveiller douleur, mobilité, état neurologique et symptômes secondaires.
- Noter information donnée au médecin et à l'équipe.

Alerte immédiate

- Appel médical rapide si douleur persistante, impossibilité d'appui, plaie, hématome important ou doute.
- Appel 15 si fracture grave suspectée, TC sévère, déficit neurologique, malaise ou détresse.

Mention de sécurité

Chute sans témoin ou résident anticoagulé = vigilance renforcée, même si l'examen initial paraît rassurant.

Fait à :

Le : / /

Signature :